

CAPÍTULO 8.19

Trauma Abdominal y Torácico

PERFIL EUNACOM 1.06.2.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Cuerpo Extraño Digestivo

Marco General

Ante cualquier sospecha de cuerpo extraño digestivo → pedir Rx de cuello + tórax + abdomen (el esófago empieza en el cuello y el tracto digestivo continúa hasta el abdomen).

Localización y Conducta

En el Esófago

- **Indicación:** extraer **siempre** (endoscopia digestiva alta)
- **Clínica del cuerpo extraño esofágico:**
 - - **Sialorrea** (no puede tragar — se acumula saliva)
 - - **Odino/disfagia**
 - - **Dolor torácico** = signo de alarma → riesgo de perforación → mediastinitis

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Dolor torácico con cuerpo extraño esofágico = perforación hasta demostrar lo contrario. Requiere extracción urgente y evaluación de mediastinitis.

En Estómago o Intestino (más allá del esófago)

TABLA 8.19.1: SITUACIÓN VS CONDUCTA

SITUACIÓN	CONDUCTA
Cuerpo extraño simple, asintomático	Observar + control Rx cada 2 semanas hasta que salga en deposiciones
Cuerpo extraño que ya apareció en deposiciones	Suspender controles
Pilas o baterías (cualquier tamaño)	Extraer siempre (aunque estén en estómago)
Imanes múltiples (≥ 2)	Extraer siempre (pueden atraparse y producir necrosis/perforación)
Cuerpos afilados o > 5 cm (cuchillas, alfileres)	Extraer siempre
Sferitas (juguetes absorbentes de agua)	Extraer siempre (pueden expandirse y obstruir)

EUNACOM CRITERIOS

No hay que buscar el cuerpo extraño en las deposiciones. Solo esperar a que salga.

Con Complicaciones (obstrucción o perforación)

- Si está más allá del esófago y tiene:
 - - Obstrucción intestinal
 - - Perforación de víscera hueca
- **Tratamiento:** cirugía (la endoscopia no llega tan distal)

Comida Impactada en Esófago

TABLA 8.19.2: SITUACIÓN VS CONDUCTA

SITUACIÓN	CONDUCTA
Sin dolor + puede tragar líquidos	Observar máximo 24 horas (puede pasar solo)
Con dolor O no puede tragar líquidos	Extraer con endoscopia
Lleva > 24 horas	Extraer con endoscopia

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Un trozo de carne impactado en esófago: si no duele y puede tragar saliva → observar 24 h. Si no pasa, duele o no traga líquido → endoscopia.

Lectura de Rx: Esófago vs. Tráquea

- **Moneda en esófago:** se ve **coronal** (de frente completa) en Rx de frente
- **Moneda en tráquea:** se ve **sagital** (de canto) en Rx de frente
- **Vía aérea:** se ve como columna oscura de aire en Rx
- Cuerpo extraño **no obstructivo en tráquea** (ej. resorte): **no hacer Heimlich** → **broncoscopia** para extraerlo

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El Heimlich (maniobra de desobstrucción) solo está indicado si hay **obstrucción completa de la vía aérea** (asfixia). Si el cuerpo extraño ya está en tráquea y no obstruye → broncoscopia.

Resumen Toma de Decisión

''' Cuerpo extraño digestivo | Esófago → Endoscopia SIEMPRE | Estómago / intestino | | Pila, imán x2, afilado, > 5 cm → Endoscopia/cirugía | | Simple, asintomático → Observar + control Rx c/2 sem | | Complica (obstrucción/perforación) → Cirugía | Comida impactada en esófago | Sin síntomas → Observar 24 h | Con dolor / sin tragar líquido / > 24 h → Endoscopia '''

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 28 años ingresa tras colisión vehicular a alta velocidad. Está taquicárdico (FC 125 lpm), hipotenso (PA 85/50 mmHg), pálido y con abdomen doloroso y distendido. En el box de reanimación se realiza Ecografía FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma) que demuestra líquido libre abundante en el espacio hepatorenal (Morrison) y en la pelvis."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Trauma Abdominal Cerrado con Shock Hipovolémico y FAST (+): la demostración de líquido libre intraabdominal (hemoperitoneo) en un paciente hemodinámicamente inestable (que no responde a volumen) es indicación formal e inmediata de Laparotomía Exploradora Urgente sin necesidad de realizar TAC.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Trauma abdominal cerrado: clínica + eco-FAST; el lavado peritoneal diagnóstico está obsoleto
- Indicaciones de exploración quirúrgica en trauma cerrado: inestabilidad hemodinámica, signos peritoneales o líquido libre ecográfico
- Rotura de víscera hueca: peritonitis difusa con neumoperitoneo; rotura de víscera sólida: hemoperitoneo
- Trauma abdominal por arma blanca: clínica + exploración digital de la herida
- Trauma abdominal por arma de fuego: cirugía siempre
- Trauma torácico (cerrado y arma blanca): clínica + radiografía de tórax con manejo de complicaciones
- Hemotórax con flujo mayor a 1.500 mL o mayor a 200 mL/hora requiere exploración quirúrgica
- Trauma torácico por arma de fuego: cirugía urgente siempre

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRAUMA ABDOMINAL Y TORÁCICO)

PREGUNTA 1

Hombre de 30 años sufre trauma abdominal cerrado por accidente automovilístico. Llega hemodinámicamente estable, con leve dolor en hipocondrio izquierdo. La eco-FAST no muestra líquido libre. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Laparotomía exploradora de urgencia
- B) Lavado peritoneal diagnóstico
- C) Observación clínica
- D) TAC de abdomen con contraste
- E) Exploración digital de la herida

PREGUNTA 2

Hombre de 25 años recibe herida por arma blanca en el abdomen. Al realizar exploración digital de la herida, se constata que penetra el peritoneo. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Observación clínica por 24 horas
- B) Eco-FAST y decidir según resultado
- C) Exploración quirúrgica
- D) Radiografía de abdomen simple
- E) Lavado peritoneal diagnóstico

PREGUNTA 3

Paciente de 40 años sufre trauma torácico cerrado. En la radiografía de tórax se observa opacidad en la base derecha con borramiento del ángulo costofrénico. Se instala tubo pleural que drena 1.800 mL de sangre en la primera hora. ¿Cuál es la conducta más apropiada?

- A) Mantener tubo pleural y observar
- B) Exploración quirúrgica
- C) Transfusión de glóbulos rojos y esperar
- D) Retirar tubo pleural e instalar nuevo
- E) TAC de tórax con contraste

RESUMEN: TRAUMA ABDOMINAL Y TORÁCICO

Clase sobre el manejo del trauma abdominal y torácico, dividido en trauma cerrado, por arma blanca y por arma de fuego. Cada tipo de trauma tiene un manejo específico que hay que conocer en detalle. En el trauma abdominal cerrado, el manejo se basa en la clínica más la ecografía de urgencia (eco-FAST). Se observa si la clínica y ecografía son normales; se explora quirúrgicamente si hay inestabilidad hemodinámica, signos peritoneales o líquido libre ecográfico. El lavado peritoneal diagnóstico está obsoleto. En el trauma abdominal por arma blanca, el manejo es la clínica más la exploración digital de la herida. Si la herida no penetra el peritoneo se observa; si penetra se explora quirúrgicamente. El trauma abdominal por arma de fuego siempre requiere cirugía. La rotura de víscera hueca produce peritonitis difusa con neumoperitoneo; la rotura de víscera sólida produce hemoperitoneo. En el trauma torácico cerrado y por arma blanca, el manejo es la clínica más la radiografía de tórax, con soporte respiratorio y manejo de complicaciones (neumotórax, hemotórax, contusión pulmonar). El trauma torácico por arma de fuego siempre requiere cirugía urgente.